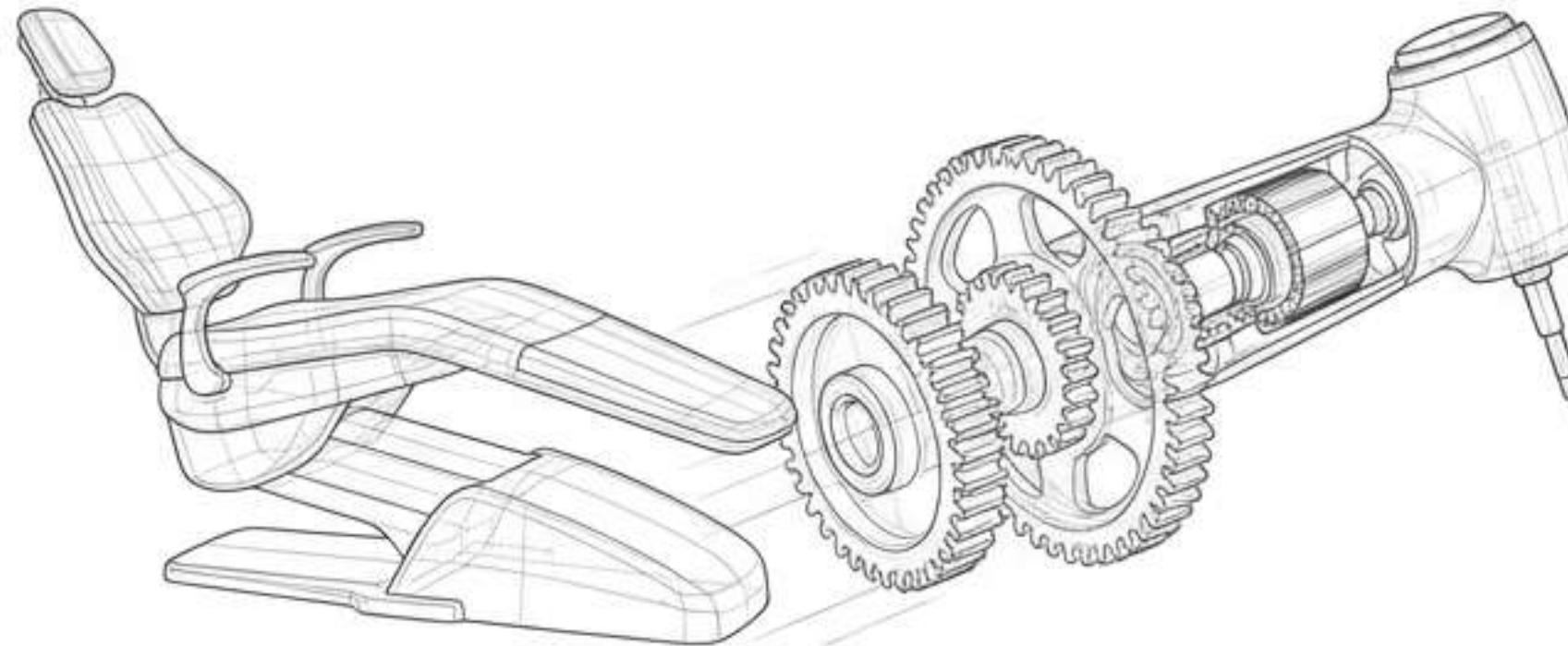


Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences de la Santé
Faculté de Médecine Dentaire
EHS MAOUCHE MOHAND AMOKRANE Ex CNMS
Service Pathologie et Chirurgie Buccales



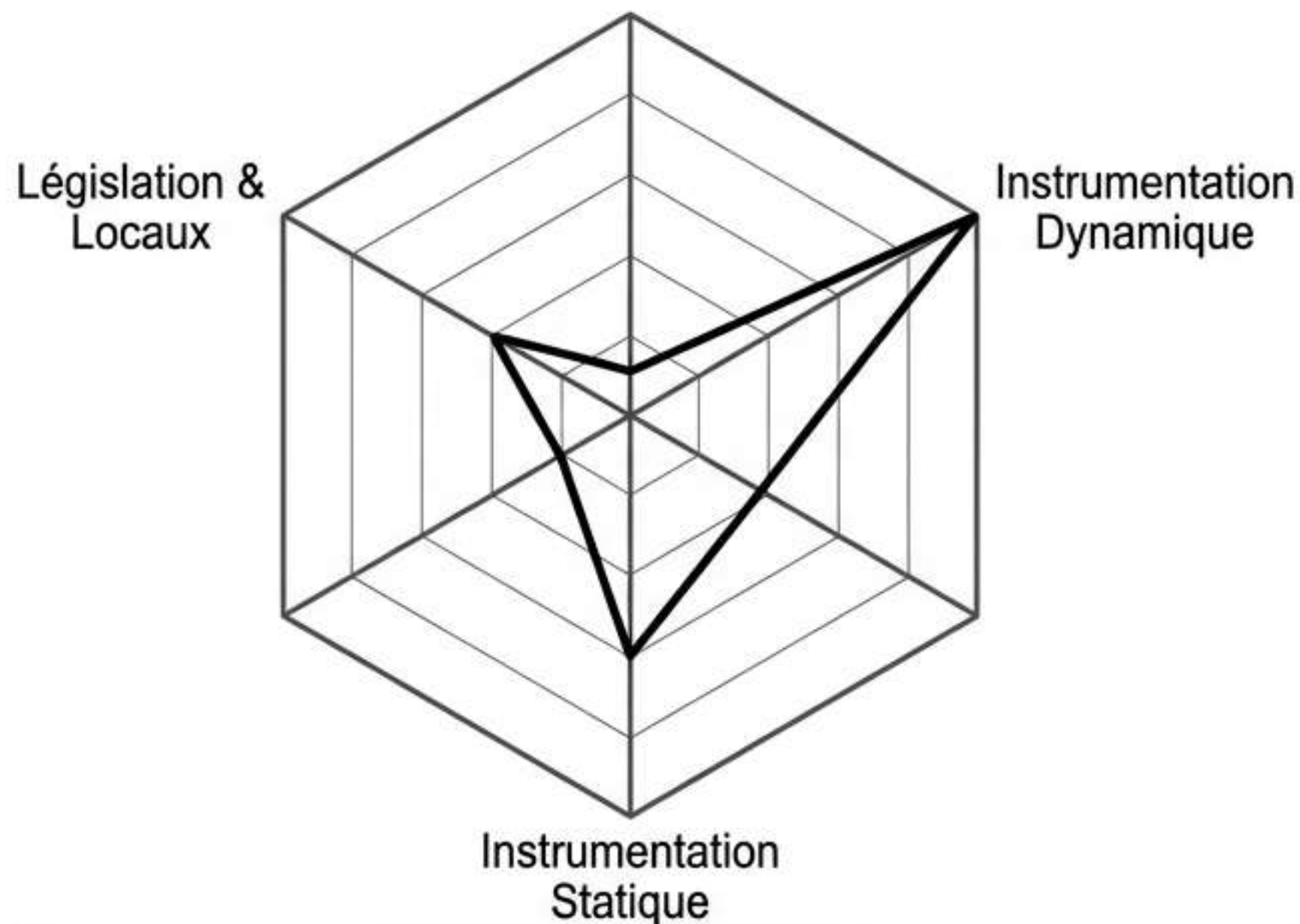
Cabinet Dentaire & Dispositifs Chirurgicaux: L'Atlas Clinique

Cours de Pathologie Bucco-Dentaire - 2ème Année (2025-2026)

Dr. SAIDI.K
EHS MAOUCHE MOHAND AMOKRANE Ex CNMS
Service Pathologie et Chirurgie Buccales

Document strict: Basé exclusivement sur le support de cours officiel. 100% de couverture de contenu certifiée.

Stratégie d'Examen & Analyse des QCM



Historique des QCM (2018-2024) cible fortement :

- **Instrumentation Dynamique**: Vitesses de rotation, sens de rotation, contre-indications osseuses [Ref: Q3, Q7, Q13]
- **Instrumentation Statique**: Fonction exacte de la Pince Gouge [Ref: Q5]
- **Équipement du Fauteuil**: Systèmes d'aspiration obligatoires [Ref: Q8]

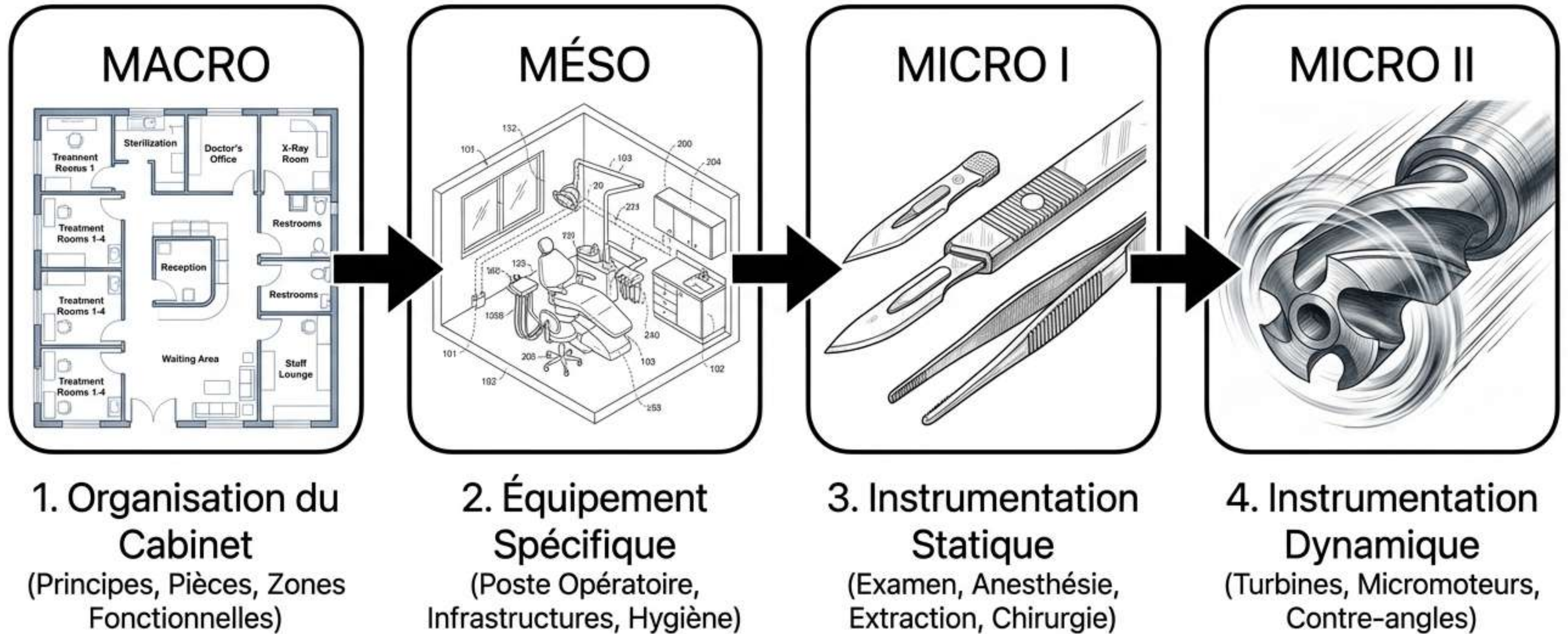
Cibles à haut risque (2025/2026) :

- **Nomenclature Chiffrée**: Numérotation des manches et lames de bistouri, volumes exacts d'anesthésie (1,7 / 1,8mL) [Predicted - High probability matching]
- **Codes Couleurs**: La matrice des bagues de contre-angles et leurs rapports [Predicted - Classic MCQ trap]

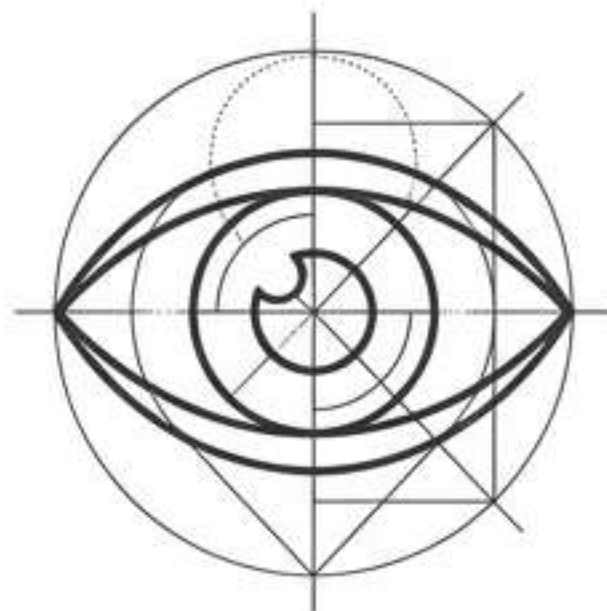


Règle d'Autorité Suprême : Ce document s'en tient strictement aux données du PDF. Les divergences rencontrées dans d'anciennes questions (ex: vitesse turbine 420k, conditions d'ouverture) sont ignorées au profit du texte officiel.

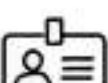
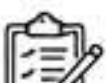
Architecture du Cours: Du Macro au Micro

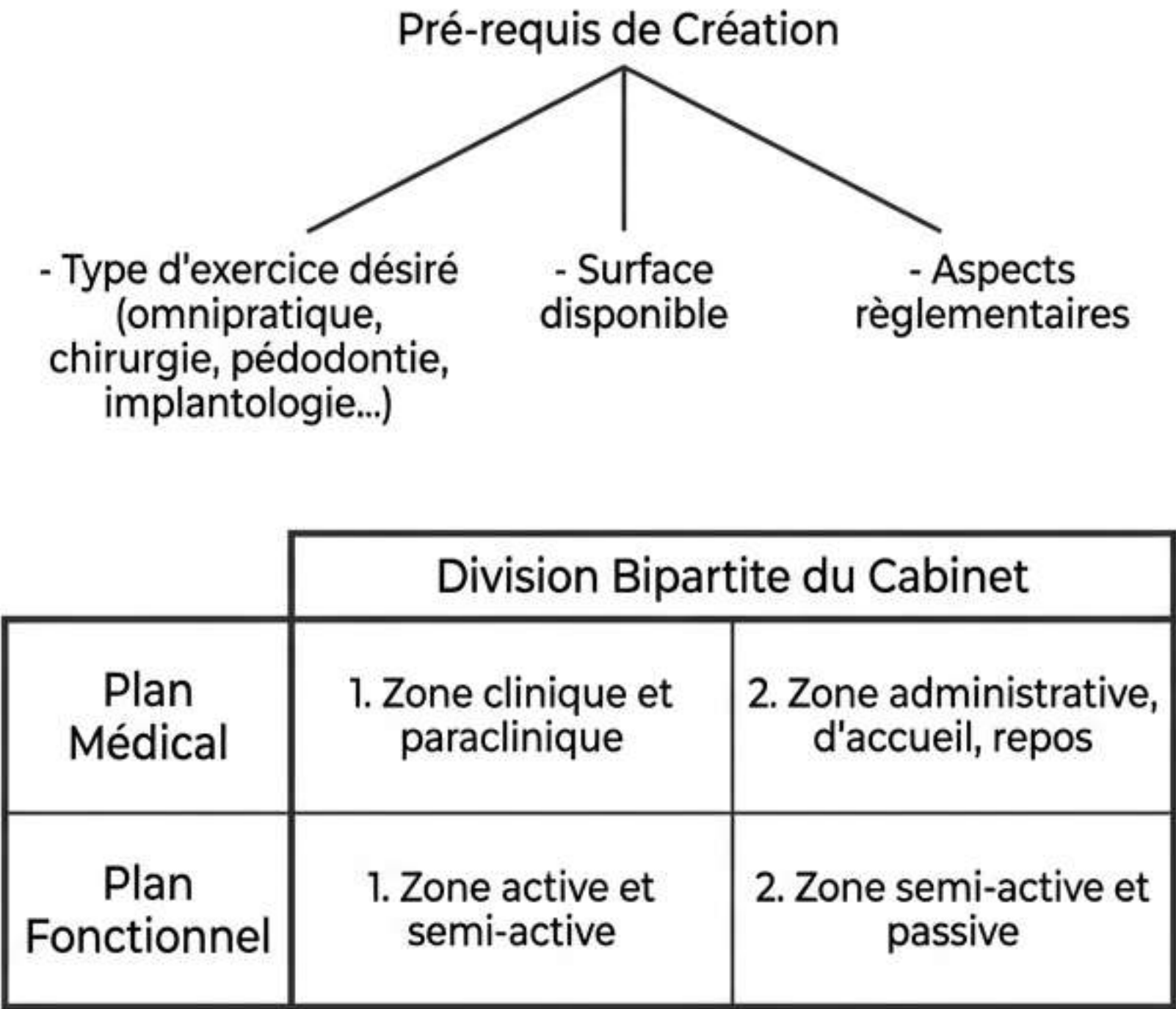


Principes de Création : Vision et Structuration



La Philosophie du Cabinet :

-  - Reflet de la vision du praticien.
-  - Si fonctionnel, esthétique et confortable -> exercice productif.
-  - Il est la « carte de visite du praticien ».
-  - Rigueur dans la planification et conception est essentielle.

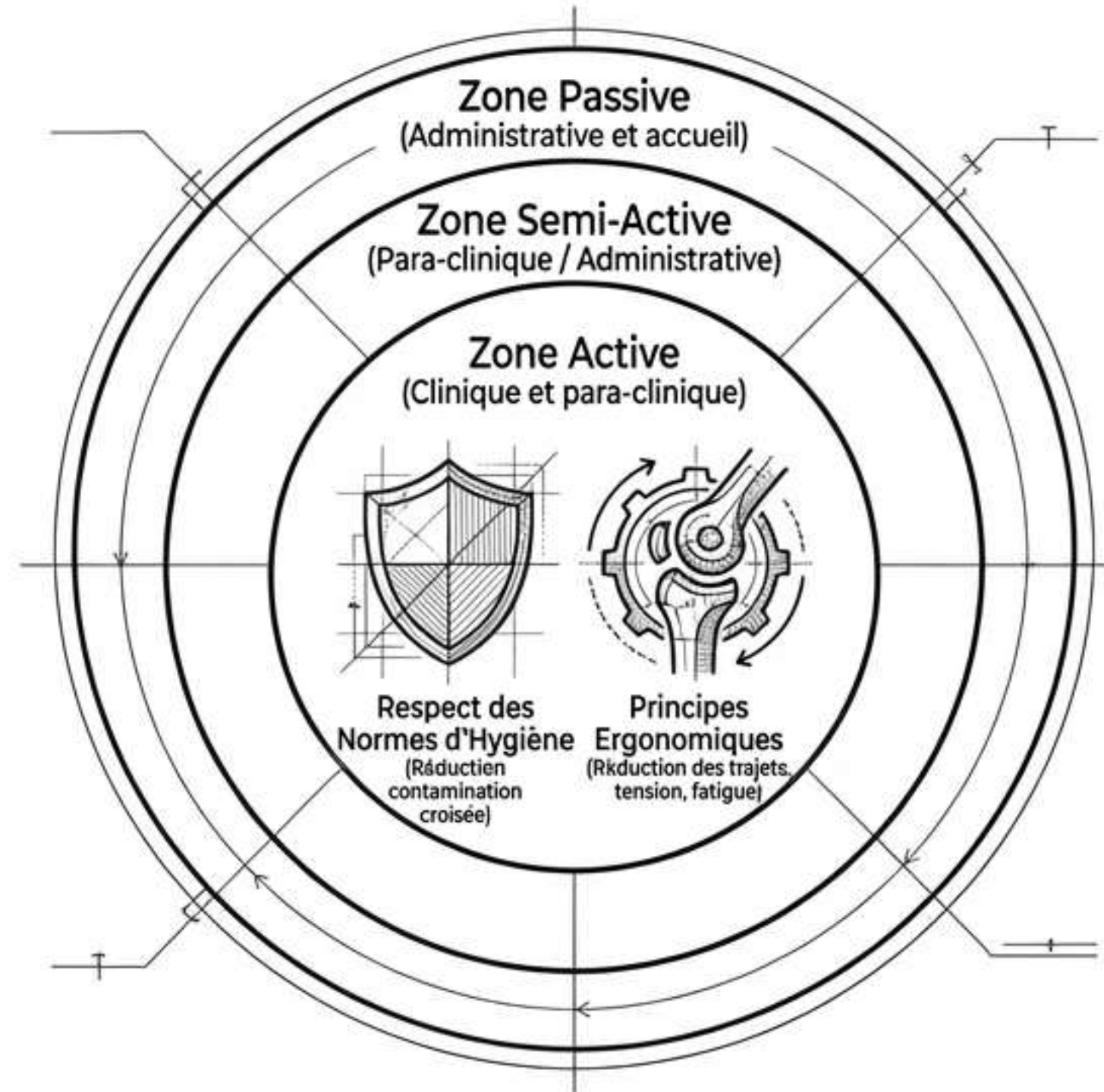


Inventaire Architectural : Les Pièces du Cabinet

Installation Minimale Obligatoire ★	Obligatoire (Si personnel) 	Facultatives (Selon moyens) +
• Accueil, secrétariat • Salle d'attente • Salle de soins • Salle de stérilisation • Zone de stockage DASRI • Local technique • Sanitaires	• Sanitaires (distincts) • Salle de repos	• Bureau privé • Salle distincte compresseur/aspiration • Salle de radiographie • Salle de chirurgie (indispensable pour implantologie/paro) • Laboratoire de prothèse

Règle Architecturale : Établir une circulation à « sens unique » pour le patient, les dispositifs médicaux, et leur décontamination-stérilisation.

Détermination des Zones Fonctionnelles



Cette séparation physique de l'espace dentaire concilie le double objectif fondamental du cabinet : l'hygiène stricte et l'ergonomie optimale pour le praticien, l'assistante et le patient.

La Zone Active : L'Unité de Production

Salle de soins

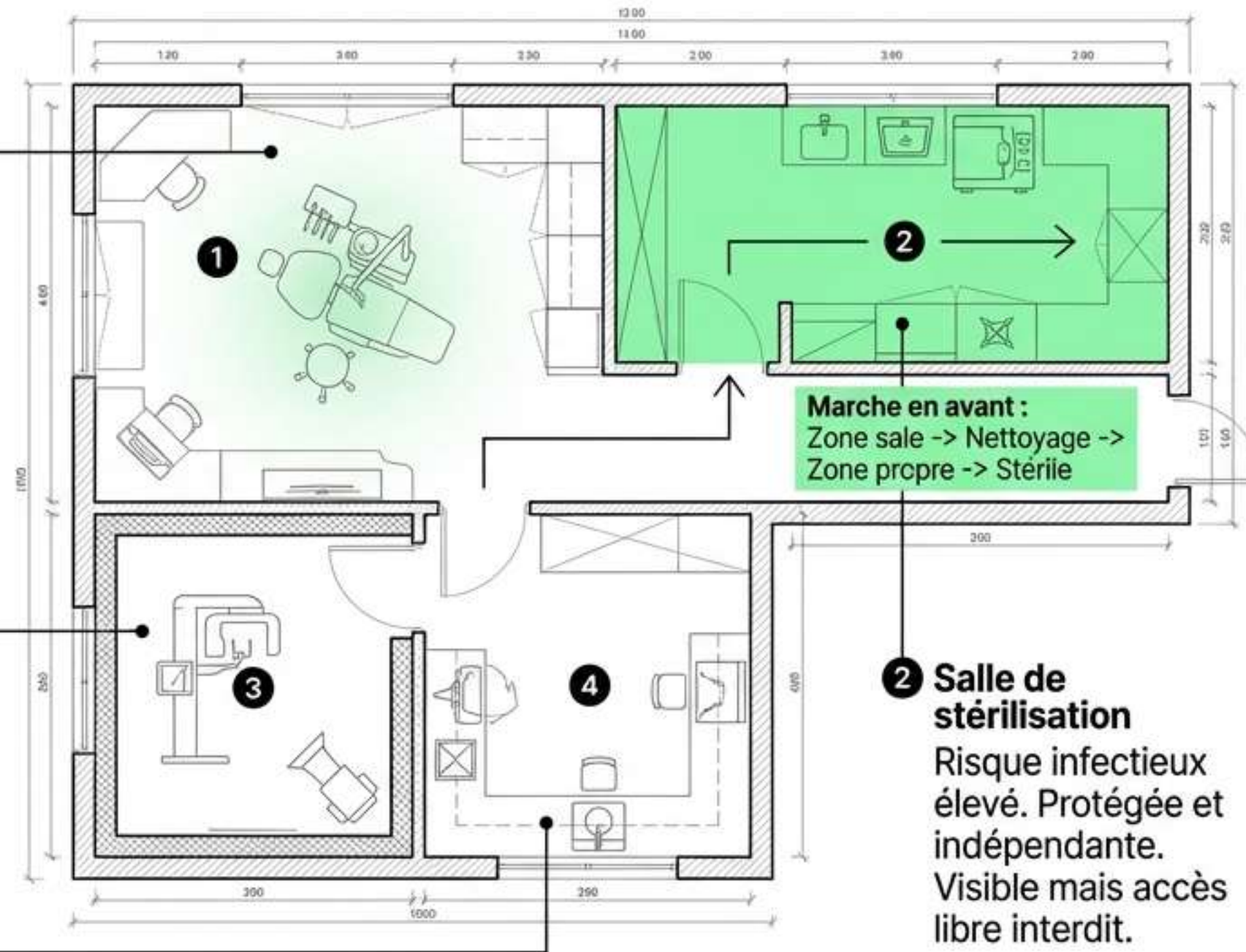
Centre névralgique incontournable.
Implantation du mobilier cruciale pour l'ergonomie.
Pour l'ergonomie.
Flexibilité requise face à l'évolution.

Salle de radiographie

Panoramique / Cone beam.
Murs = rôle d'écran contre rayonnements.

Laboratoire de prothèse

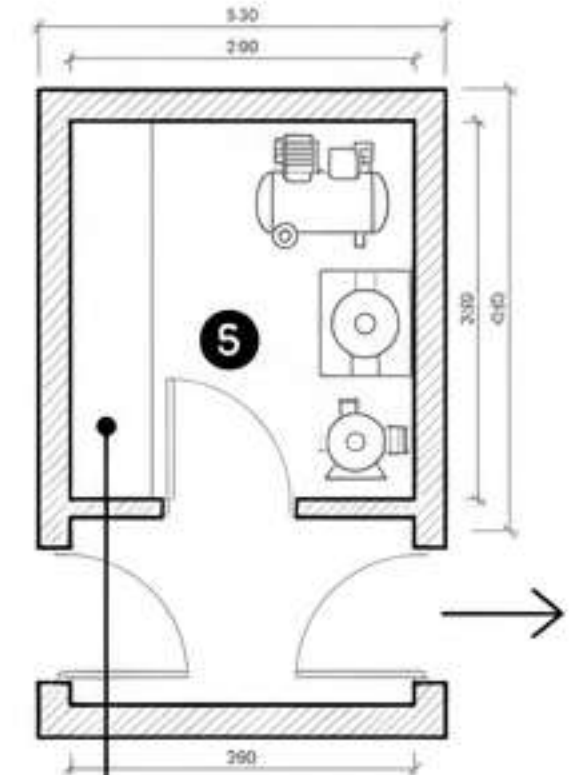
Exécution des étapes de laboratoire.



Marche en avant :
Zone sale -> Nettoyage ->
Zone propre -> Stérile

2 Salle de stérilisation

Risque infectieux élevé. Protégée et indépendante.
Visible mais accès libre interdit.

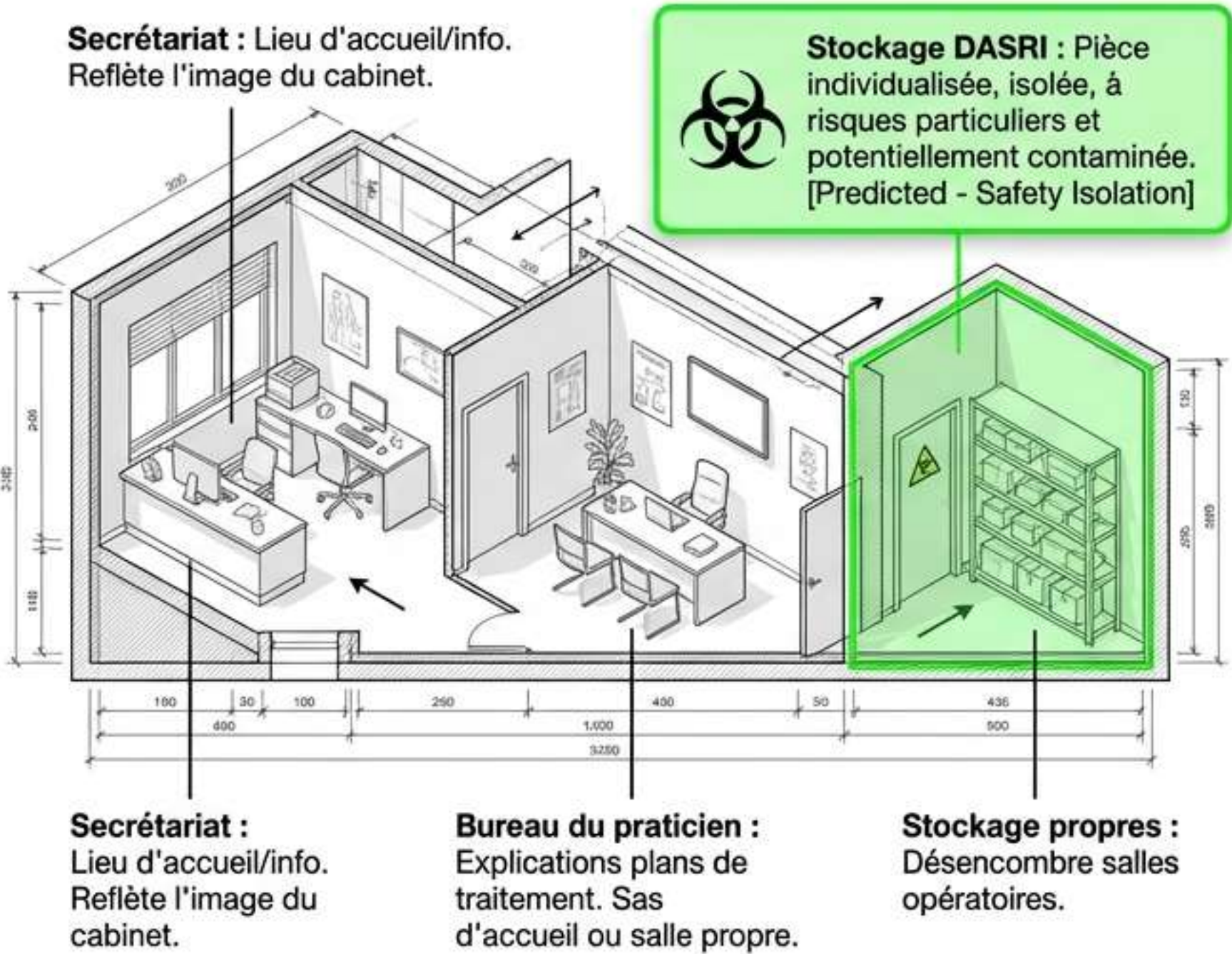


5 Local technique

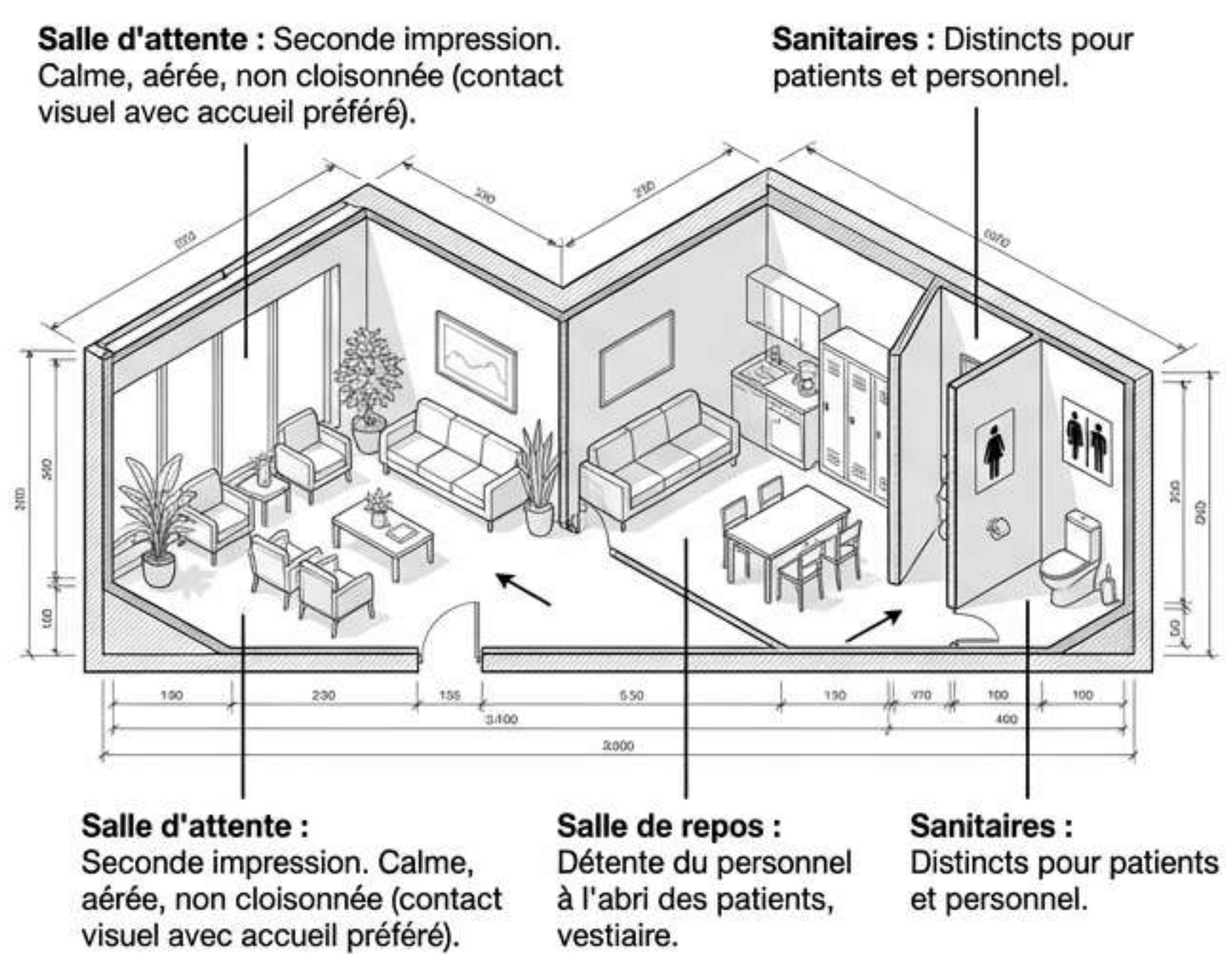
Abrite compresseur, moteur d'aspiration, surpresseur.
Endroit isolé, porte d'accès sur l'extérieur.

Zones Semi-Active & Passive

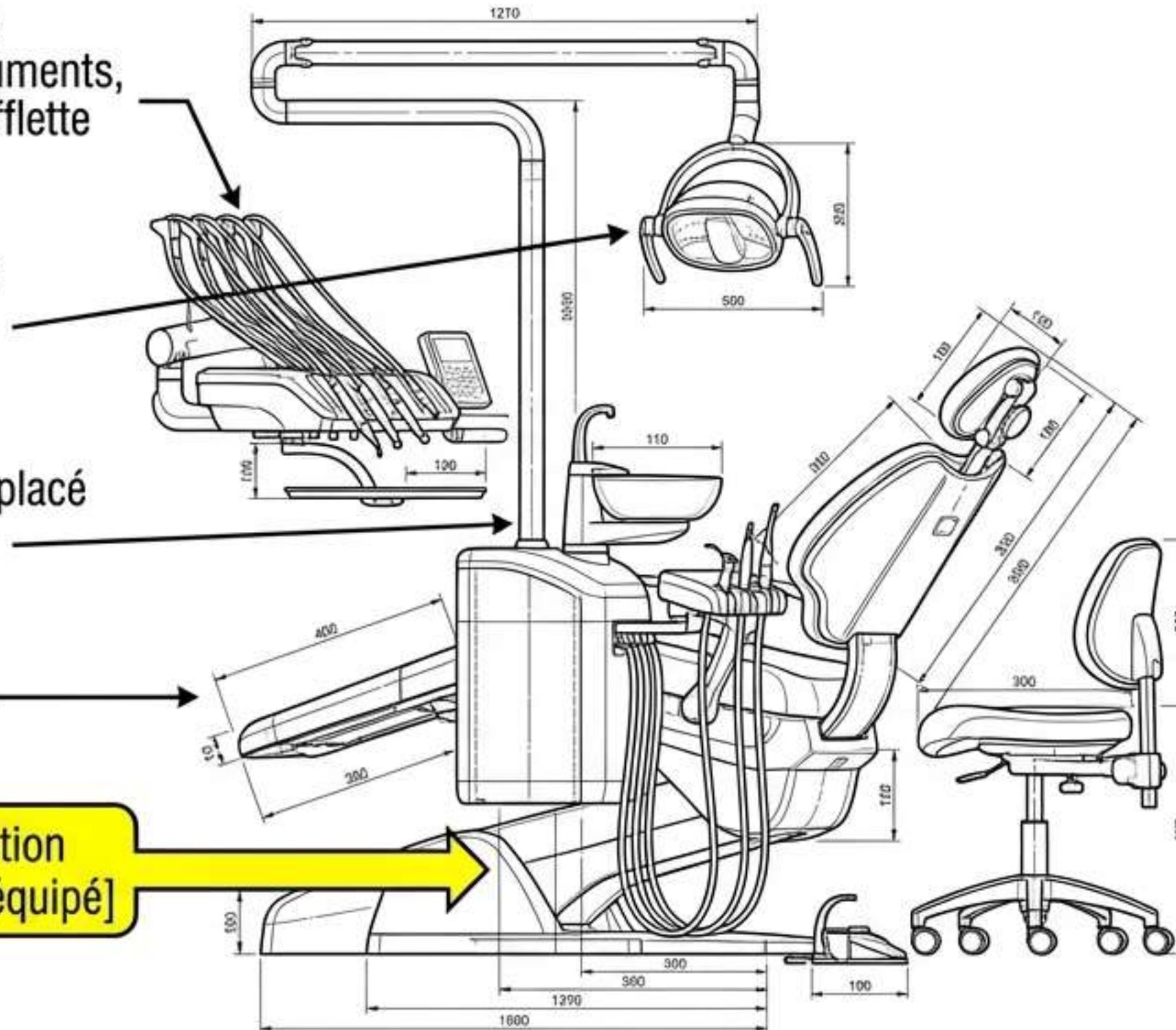
Zone Semi-Active (Activité moins intense, pas de soins)



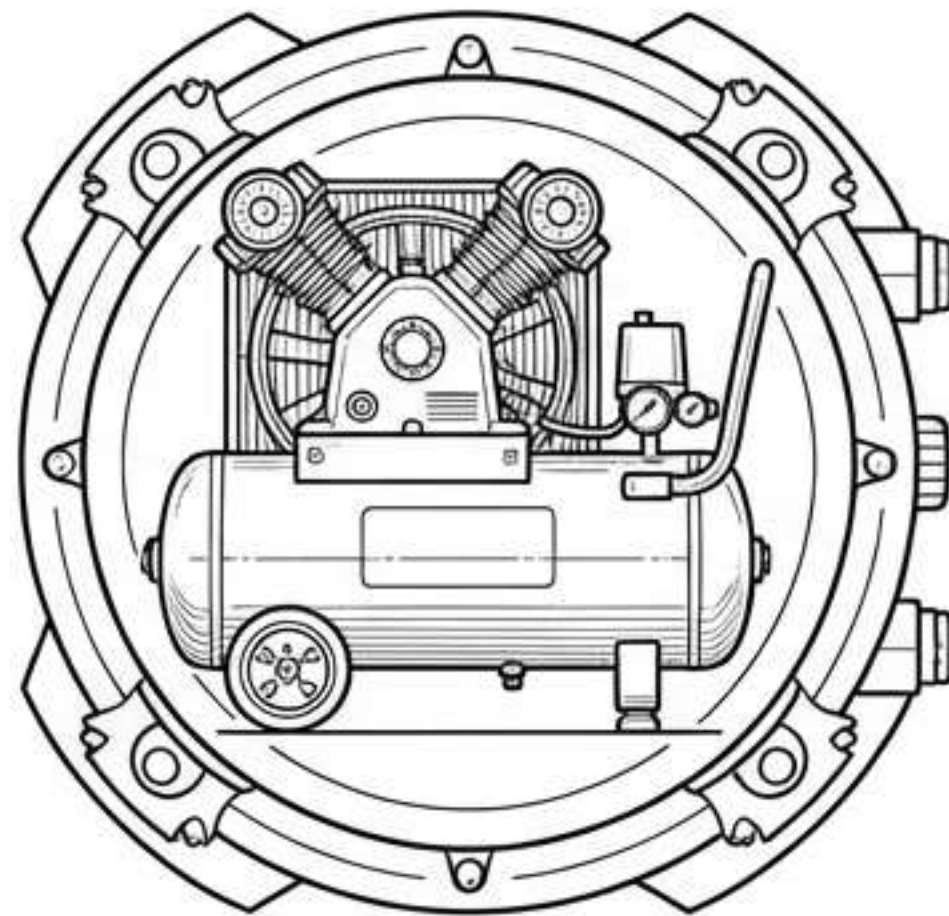
Zone Passive (Fréquence faible, repos)



Système d'aspiration
[Ref: Q8 - Toujours équipé]

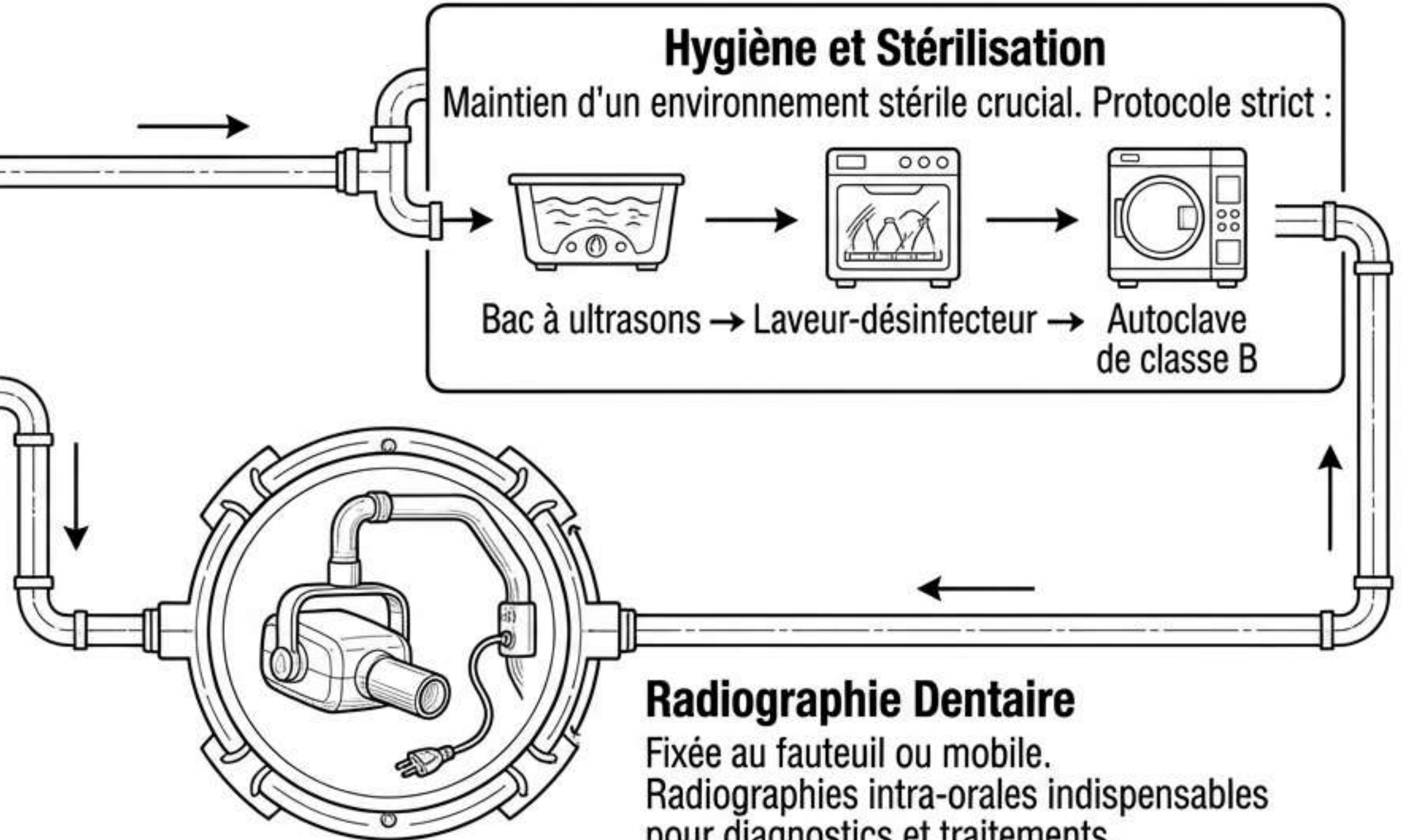


Infrastructures Vitales : Énergie, Stérilisation et Imagerie



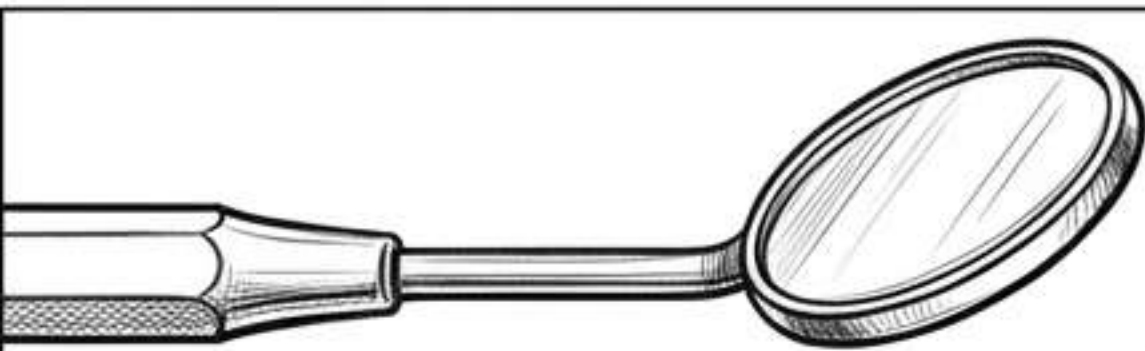
Le Compresseur

Le véritable « poumon » du cabinet.
Alimente en air comprimé absolument
tous les instruments rotatifs.



Instrumentation Statique I : Instruments d'Examen

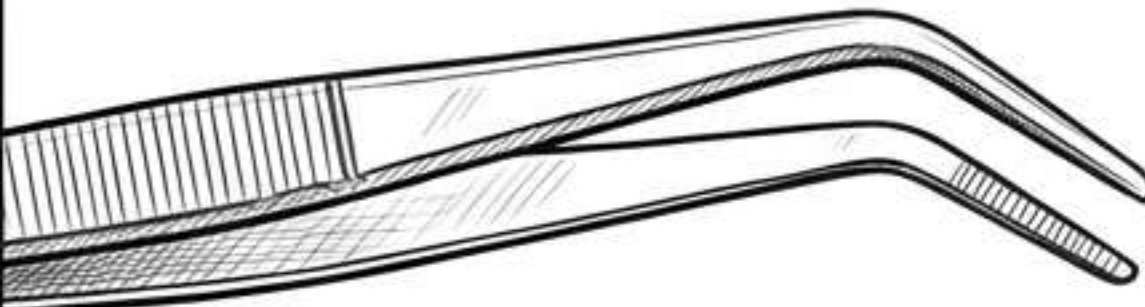
Fonctionnent sans source d'énergie. Base de toutes les interventions.



Miroirs dentaires : Vision indirecte et écartement des joues et lèvres.



Sondes exploratrices : Extrémité POINTUE. Détection des caries et irrégularités (restaurations défectueuses).



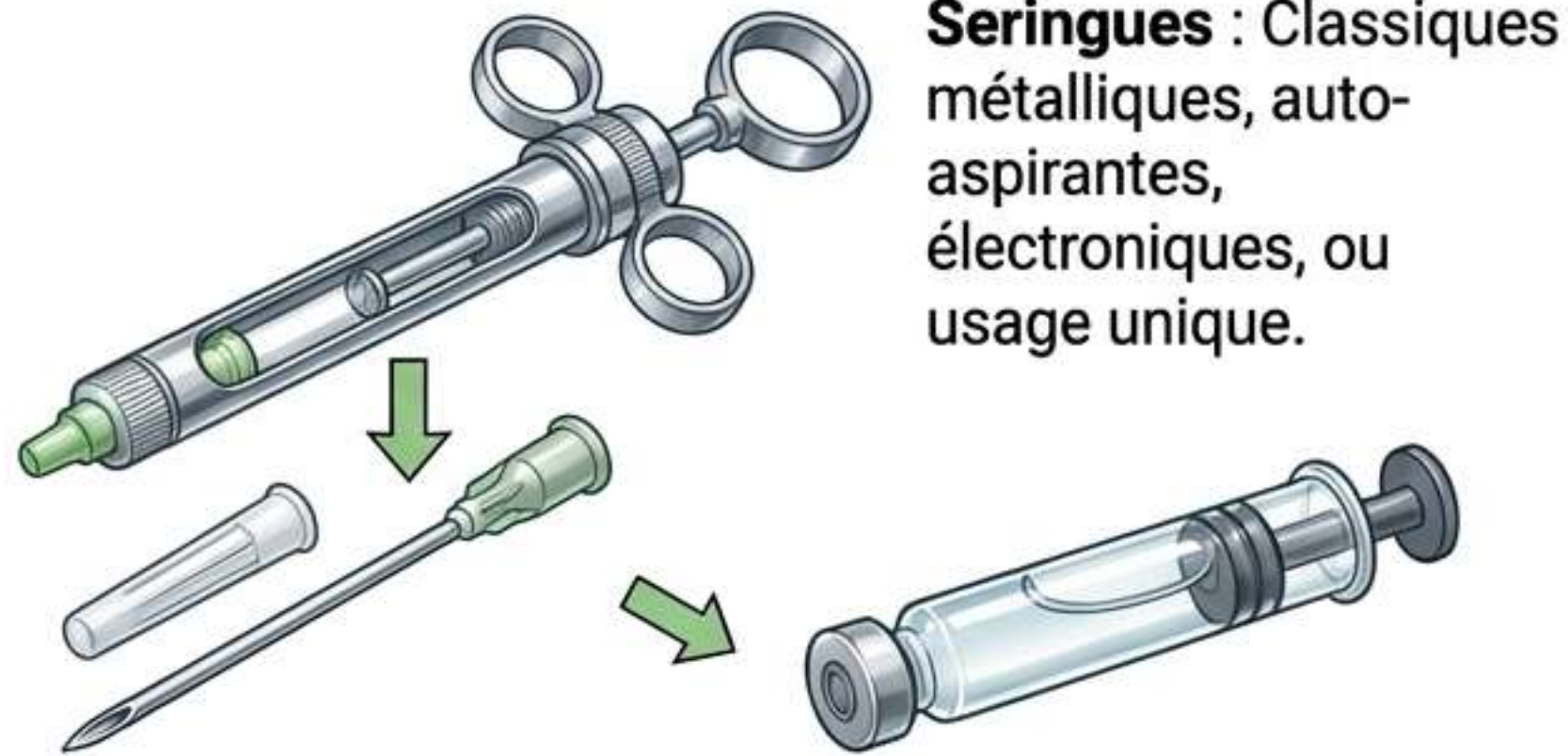
Précelles : Manipulation précise de petits objets/matériaux, ergonomie optimisée.



Sondes parodontales graduées : Évaluation de la santé parodontale (sondage). Tige graduée à bout ÉMOUSSÉ.

Instrumentation Statique II : Anesthésie et Extraction

Anesthésie

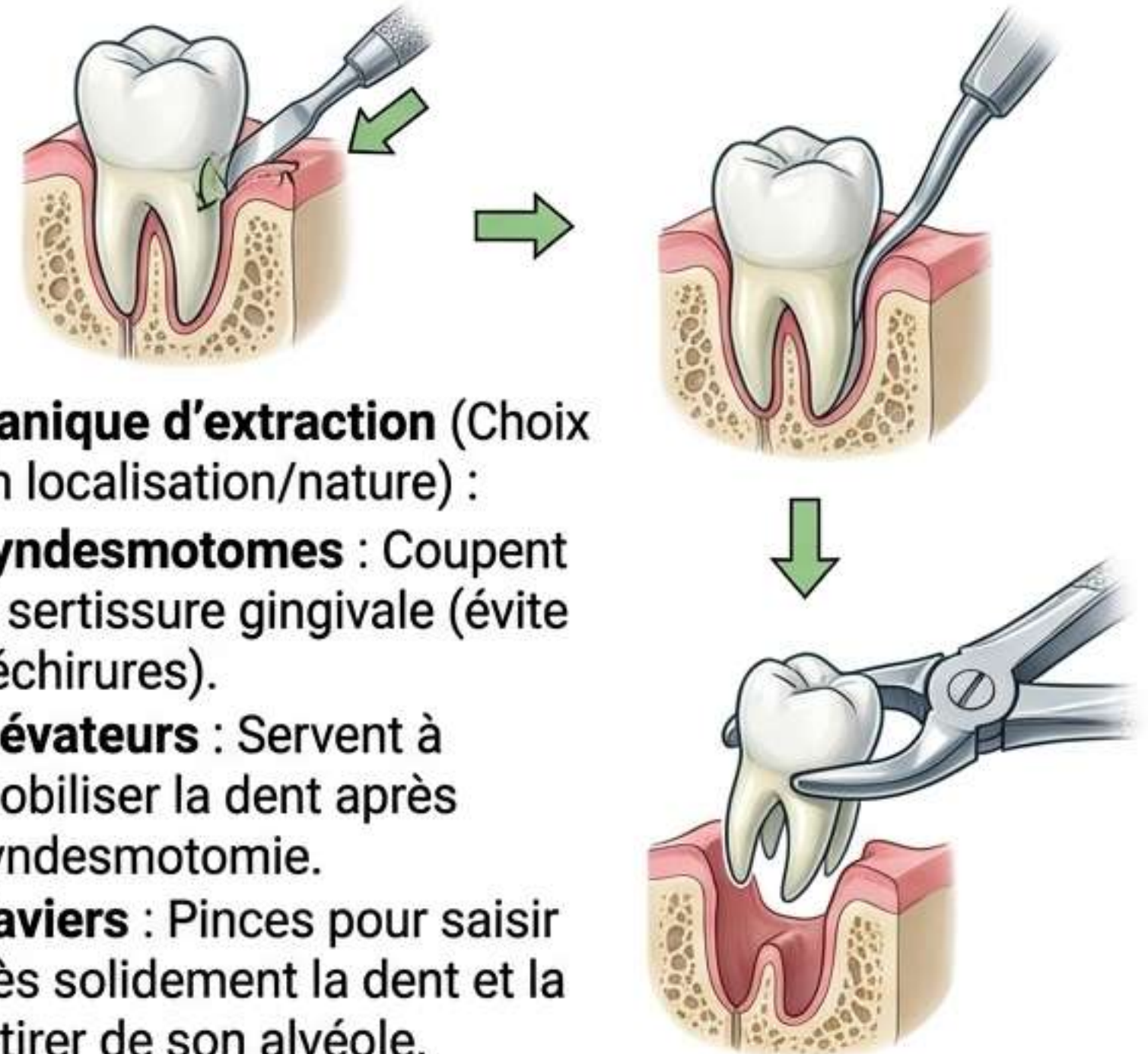


Seringues : Classiques métalliques, auto-aspirantes, électroniques, ou usage unique.

Aiguilles : Toujours bi-pointes, stériles et à usage unique. Choix par calibre/longueur. [Predicted]

Solutions : Cartouches en verre. Volume strict de 1,7 ou 1,8mL. [Predicted - High Risk MCQ]

Extraction Dentaire

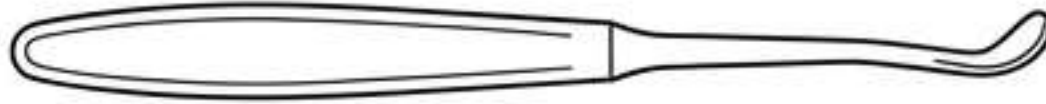


Mécanique d'extraction (Choix selon localisation/nature) :

1. **Syndesmotomes** : Coupent la sertissure gingivale (évite déchirures).
2. **Élévateurs** : Servent à mobiliser la dent après syndesmotomie.
3. **Daviers** : Pincettes pour saisir très solidement la dent et la retirer de son alvéole.

Instrumentation Statique III : Curetage et Incision

Curetage:



Curettes : Débridement des tissus de granulation/infectieux.
(Ex: Lucas, Hemingway, Mitter...)

Incision - Règle des Manches:

Lames de bistouri : Premier temps chirurgical (sectionner tissus mous).
Porte-lames plats, ronds, ou angulés.
Règle absolue : **[Predicted - Classification Match]**

Manche n°4



Lames à partir de 20

Manche n°3



Lames à partir de 10

Manipulation Tissulaire:



Décolleurs :
Partie active MOUSSE.
Simple (Williger) ou double (Molt).
Élévation délicate.



Écarteurs :
Visibilité du site.
Facilite accès, incisions et sutures.
Formes selon localisation.

Clinical Blueprint & Technical Atlas

Instrumentation Statique IV : Suture et Instruments Divers

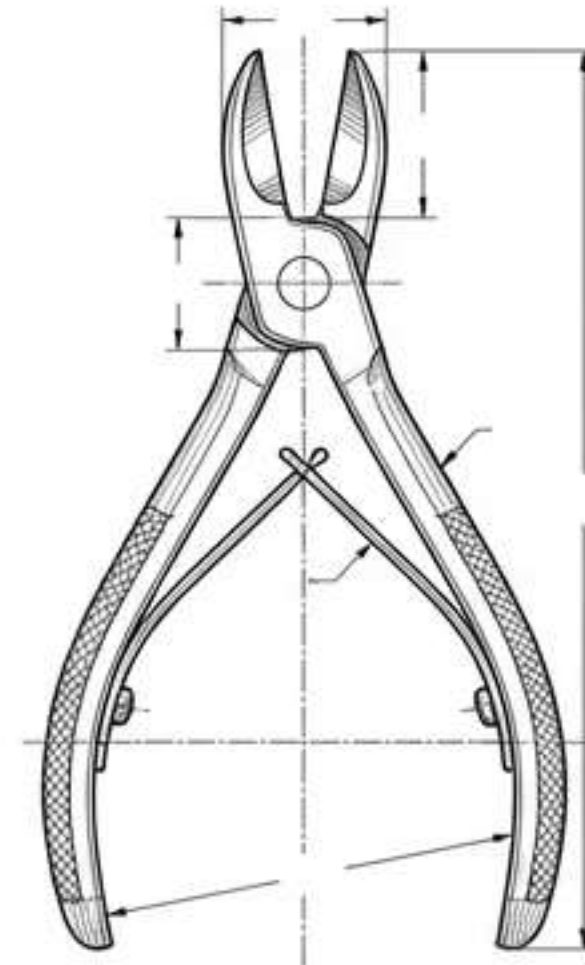
Suture:

- **Porte-aiguilles** : Pinces à crémaillère, extrémité mousse avec striations croisées.
- **Fils de suture** : Résorbables/non-résorbables. Aiguille sertie ronde/triangulaire. Différents calibres.
- **Précelles à tissu** : Mors crantés, préhension atraumatique du lambeau pour passage d'aiguille.
- **Ciseaux à suture** : Fins et pointus, affûtés pour couper précisément sans déchiqueter.

Instruments Divers:

Pinces hémostatiques : Clamper les vaisseaux, contrôler hémorragies.

Râpes à os : Doubles, râpe à larges pans, forme légèrement concave.

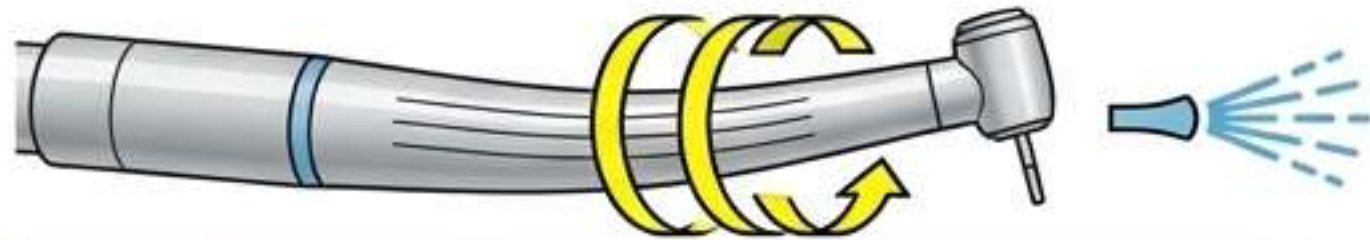


Pinces gouge : Manches articulés avec ressort. Mors symétriques tranchants. Utilisée pour régulariser les bords des plaies osseuses et éliminer les esquilles/rebords alvéolaires fins. [Ref: Q5]

Instrumentation Dynamique I : Énergie et Générateurs

Actionnés par énergie (électrique/pneumatique) via cordons multicanalaires conduisant air/eau.

Turbines (Pneumatiques)



VITESSE MAX: 400 000 rotations/mn.

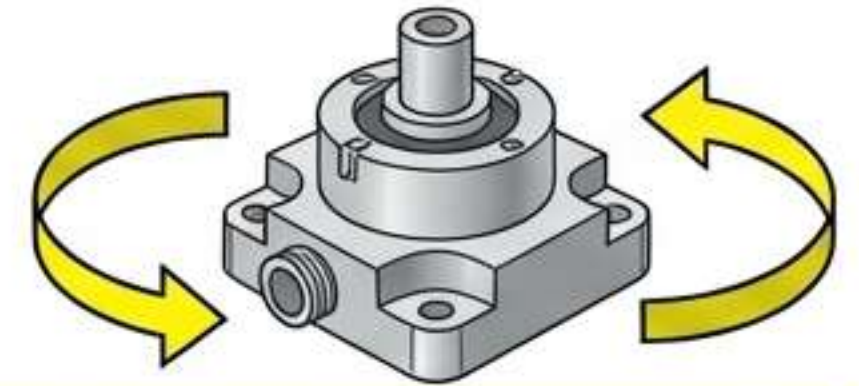
INDICATION: Réservée au travail sur l'émail dentaire.

DANGER: Contre-indiquée formellement sur tissu osseux !

[Ref: Q3, Q7]

Entrainement à air. Échauffement rapide exige un jet d'eau de refroidissement continu et obligatoire.

Micromoteurs



VITESSE: Sortie variable jusqu'à 40 000 tours/mn.

SENS DE ROTATION:

Réversible. Choisi par l'opérateur.

FONCTION: Permet l'insertion des contre-angles et pièces à main. [Ref: Q13]

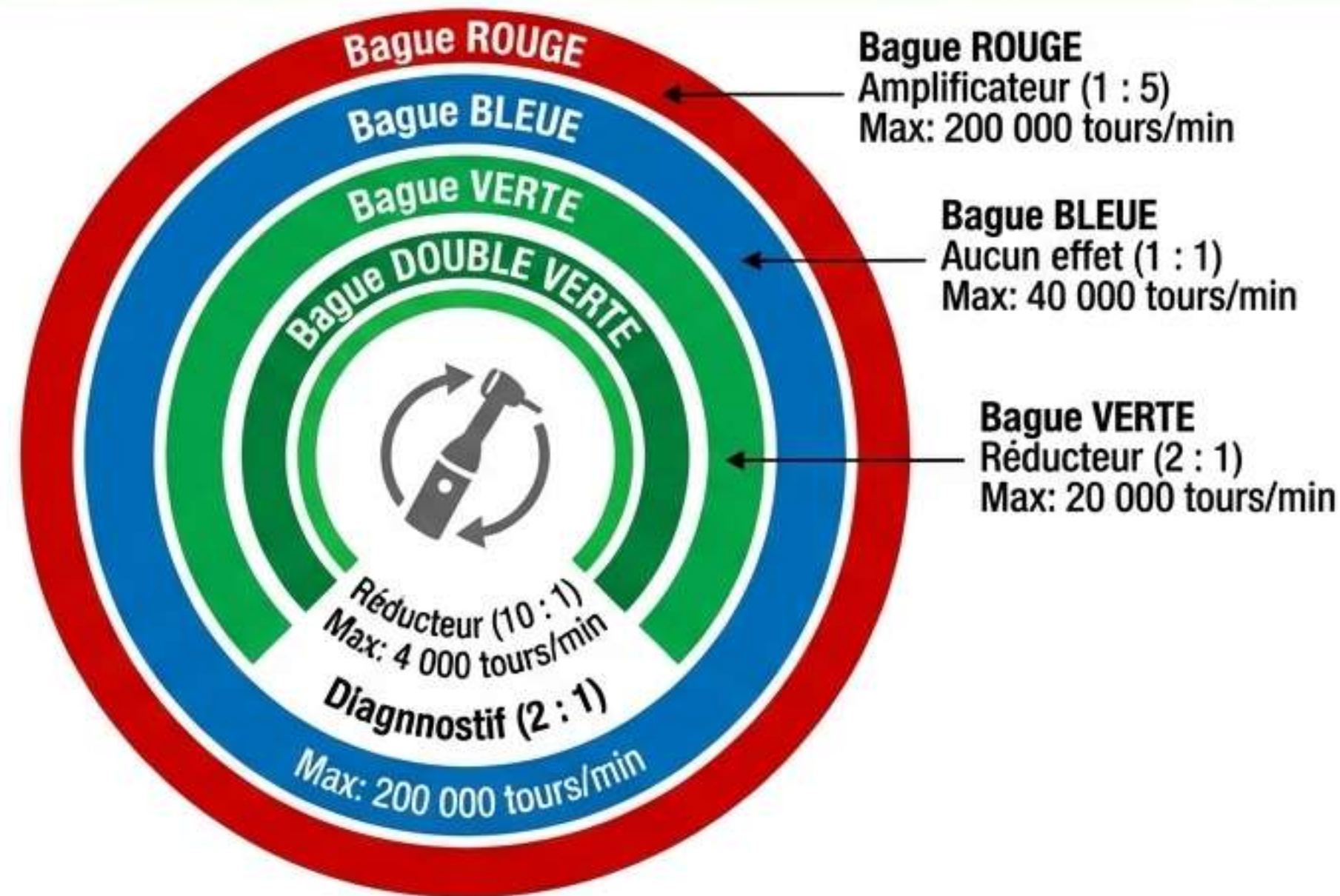
Actionnés par courant électrique ou air comprimé.

Clinical Blueprint & Technical Atlas

Instrumentation Dynamique II : Contre-Angles et Séquenceurs

Entraînés par le micromoteur. Utilisés sur le tissu dentaire et sur l'os.

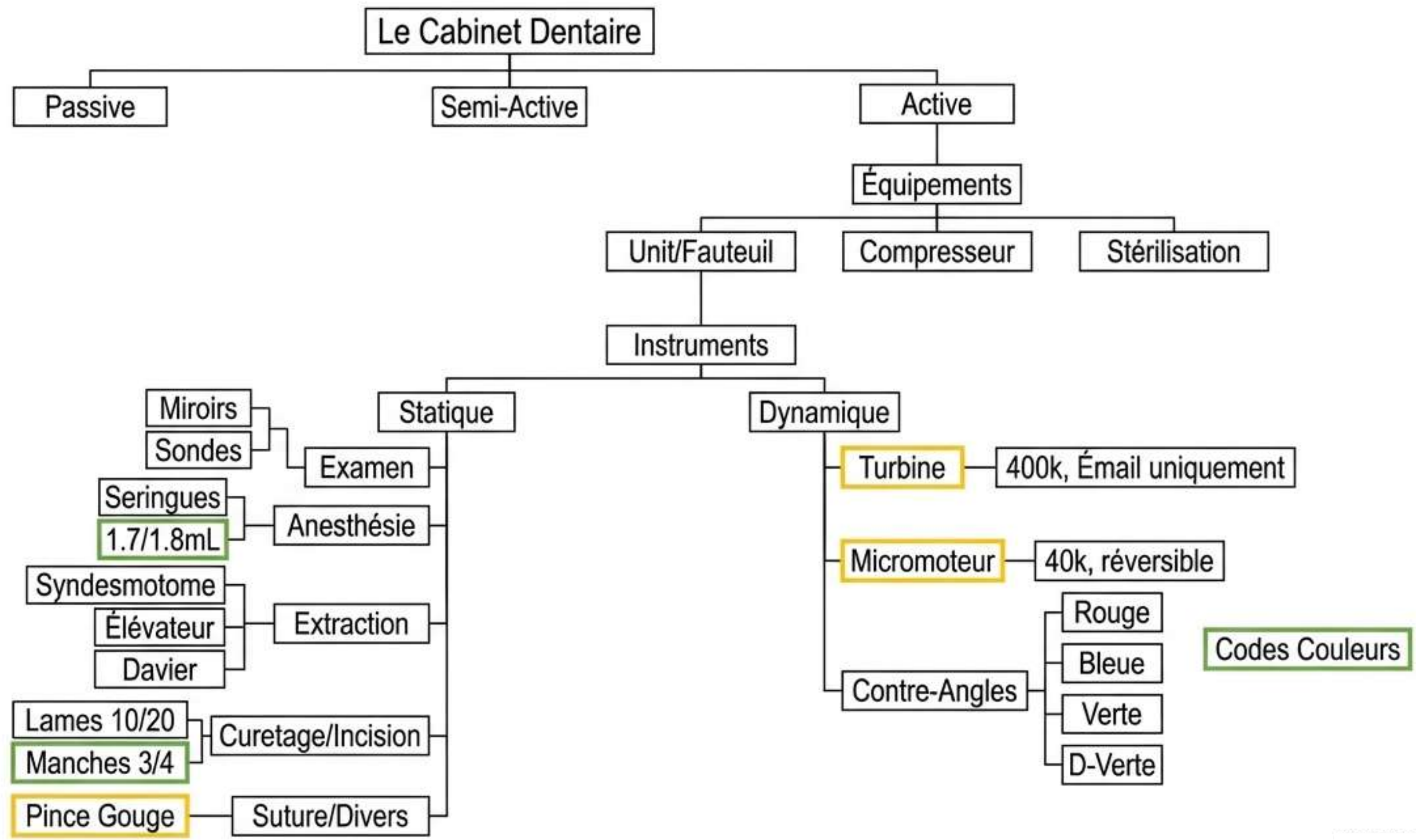
LA MATRICE DES CODES COULEURS [Predicted - Granular MCQ Data]



Séquenceurs (Jeu de fraises) : Tranchants, diverses tailles (boule, cylindrique), diamantés ou carbure de tungstène.
Usages: Trépanations osseuses et sectionnement.

Clinical Blueprint & Technical Atlas

Synthèse Globale : L'Arbre Taxonomique Clinique



Clinical Blueprint & Technical Atlas



**PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission detected.**

*La maîtrise de ces dispositifs et de cette architecture rigoureuse garantit
la sécurité absolue et l'efficacité de vos futurs actes cliniques.*